

Indicaciones

Indicaciones maternas	Indicaciones fetales
- Agotamiento de la madre - ya no puede pujar - Segunda fase del trabajo de parto prolongada - Mujeres que ya tienen cesárea, pero el feto ya bajo, tenemos que evitar que pujan***. - Enfermedades preexistentes o durante el parto que limitan los pujidos efectivos o requieren de un nacimiento rápido	- Frecuencia cardíaca fetal preocupante - Desprendimiento prematuro de placenta - Presentación podálica - Presentaciones en cara ya con indicación para CESÁREA mejor

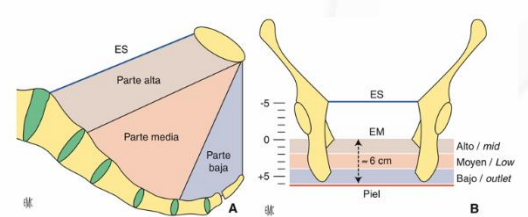
Enfermedades preexistentes: Insuficiencia pulmonar grave o aguda, la descompensación por una infección durante el parto, las enfermedades neurológicas y las enfermedades cardíacas graves.

Clasificación y requisitos

Estación y la rotación constituyen los **factores de riesgo** más importantes tanto para la madre como para el feto.

Clasificación:

- Estación se mide en cm
- Altura** de la presentación fetal: Estrecho pélvico superior o inferior
*Ya no se utilizan fórceps altos
- Salida baja (IV), bajos (VI – III), mediano (III)
- **Bajos (>+2) y medios (<+2)**, la mayoría son bajos.
- **Fórceps altos:** se aplica por arriba de la estación 0, **YA NO SE UTILIZA** en la obstetricia actual.
- **Rotación** de la cabeza fetal: sin / con rotación
- **Extracción con ventosa:** feto **NO DEBE SER** menor de 34 SDG, por el riesgo de hemorragia craneal



CUADRO 29-1. Requisitos y clasificación del parto vaginal quirúrgico según la estación y rotación.^a

Procedimiento	Criterios	
Fórceps de salida baja	La piel cabelluda es visible en el introito sin separar los labios El cráneo fetal alcanza el piso pélvico La cabeza fetal está en el perineo La cabeza está en OA u OP o La cabeza está en OA derecha o izquierda o posición OP, pero con rotación $\leq 45^\circ$	
Fórceps bajo (2 tipos)	La estación fetal se encuentra a ≥ 2 cm, pero no en el piso pélvico y: (a) Se requiere rotación $\leq 45^\circ$ o (b) Se requiere de rotación $> 45^\circ$	
Fórceps medio	La estación fetal se encuentra entre 0 y +2 cm	
Requisitos		
Cabeza encajada	Operador con experiencia	Sin coagulopatía fetal
Presentación de vértice ^{b,c}	Rotura de membranas	Sin trastorno de desmineralización fetal
Posición conocida de la cabeza fetal	Cuello uterino con dilatación completa	Consentimiento informado firmado
No se sospecha CPD	Anestesia adecuada	Disposición para abandonar el OVD
Peso fetal calculado	Vejiga materna vacía	

^aLa clasificación del parto con ventosa es igual que con fórceps con excepción de que se usa una ventosa para la tracción, mas no para la rotación.

^bPara extraer una presentación de cara-mentón anterior se puede usar fórceps, pero no ventosa.

^cEl fórceps de Piper se puede usar para extraer la cabeza durante el parto pélvico.

CPD, desproporción cefalopélvica; OA, occipito anterior; OP, occipito posterior; OVD, parto vaginal quirúrgico.

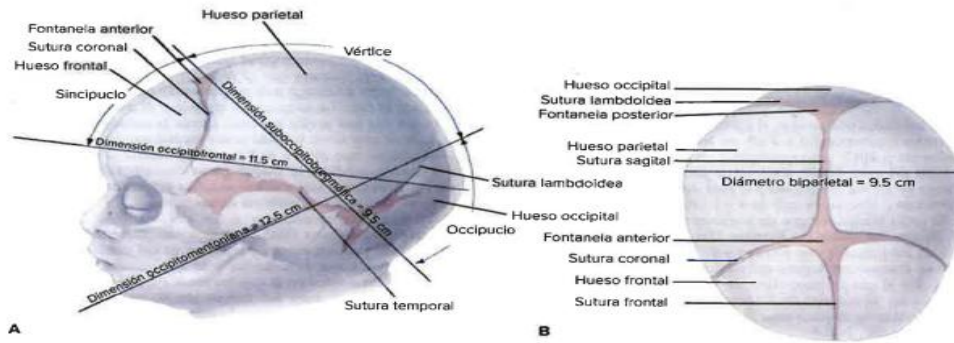


FIGURA 29-1 Cabeza fetal al término (A-B) que muestra sus fontanelas, suturas y diversas dimensiones.

Requisitos para su aplicación:

- Altura de la mesa más arriba de nosotros
- Analgesia epidural (**se prefiere regional** o bloqueo del pudendo)

DISEÑO:

- **Fórceps:** se refiere al instrumento con un par de cucharas llamadas ramas, diseñadas para usar en el lado derecho o izquierdo.
- **Rama:** hoja, mango, cerradura y manija.
- **Hoja:** punta, un pedículo y dos curvas.
 - Curva cefálica se acopla a la cabeza fetal redondeada.
 - Curva pélvica hacia arriba corresponde a la curva del canal del parto
- **Fórceps seudofenestrado:** hoja es lisa en el lado materno pero dentada en la superficie fetal interna, para reducir deslizamiento de la cabeza
- **Mangos:** cuando aprietan, aumentan las fuerzas de compresión contra la cabeza fetal. Las fuerzas que se deben tomar en consideración son **TRACCIÓN Y COMPRESIÓN**.

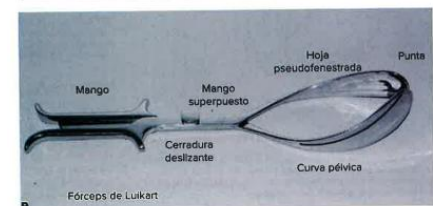
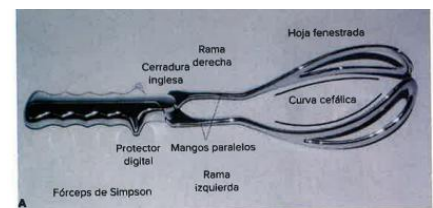


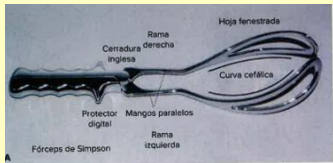
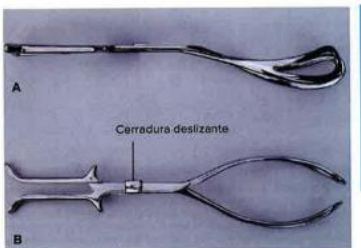
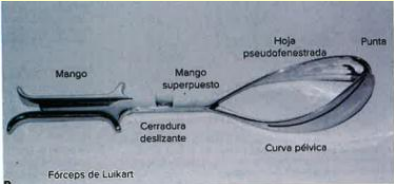
FIGURA 29-2 A. El fórceps de Simpson tiene ramas fenestradas, mangos paralelos y cerradura inglesa. La curva cefálica se adapta a la cabeza fetal. B. El fórceps de Luikert tiene ramas fenestradas, mangos superpuestos, una cerradura deslizante y manijas con lengüetas en una ranura. En este ejemplo se señala la curva pélvica (curva negra).

Hojas	Mangos	Articulaciones
→ Hojas solidas: superficies lisas → Hojas fenestradas o seudofenestradas: orificio o depresión a lo largo de su superficie.	Conexión con la hoja → Mangos paralelos: limitan la compresión de las hojas contra la cabeza fetal, *Partos que requiere mucha fuerza *agregan espesor contra el introito → Mangos superpuestos: aumentan las fuerzas de compresión, pero distienden menos el perineo.	Ayudan a unir la hoja derecha con la izquierda y estabilizan. → Articulación inglesa: al final de la hoja cerca del mango → Articulación de eje: al final de las hojas → Articulación deslizante: a lo largo del mango

Función de los fórceps:

- Tracción de la cabeza fetal
- Rotación de la cabeza fetal
- Facilitar la expulsión fetal

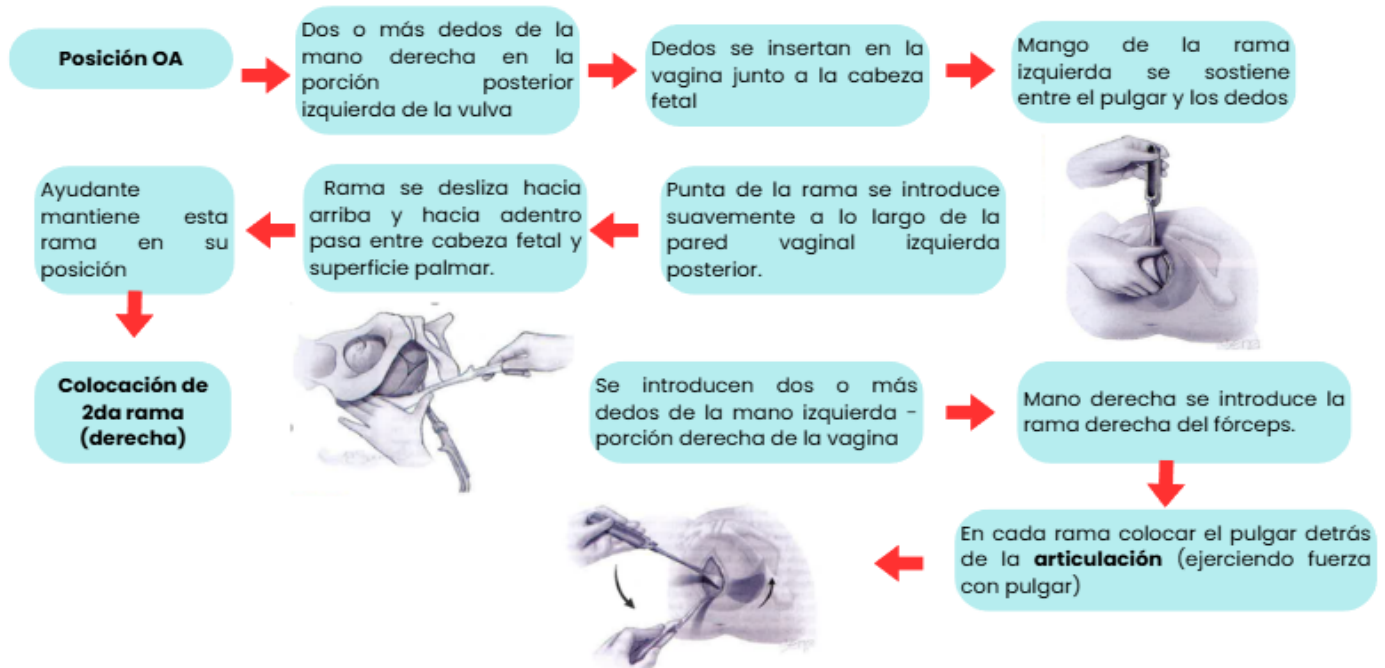
Tipos de fórceps:

Fórceps	Hojas	Articulación	Mangos	Kielland
SIMPSON 	Fenestradas – Curvatura cefálica muy marcada	Inglesa	Paralelos	Cabeza OA baja/salida Primiparas
TUCKER-MCLANE 	Solidas - redondeadas	Inglesa	Superpuestos	OA Cabeza no moldeada Multiparas
KIELLAND  FIGURA 29-12 Fórceps de Kielland. Sus características principales son la curvatura pélvica mínima (A), la cerradura deslizante (B) y su peso ligero.	Fenestradas Curvatura cefálica muy marcada y pélvica mínima.	Deslizante – peso ligero	Superpuestas 3D1	Rotar de OP a OA – por la curvatura pélvica mínima OT Medio
LUKART 	Seudofenestradas	Deslizante	Superpuesto - Manijas con lengüetas en la ranura	Similar a Kielland (menos usado) Ascintilismo
PIPER 	Fenestrado – Curva pélvica invertida y cefálica marcada	Inglesa	Superpuestos	Parto pelvico
SALINAS 	Solidas	Inglesa	Superpuestos	Salida baja

Preparación para el parto:

- Posición de litotomía dorsal con vejiga vaciada
- Cubrir con campos qx y prepara vagina y perineo de manera normal
- Si se va a utilizar anestesia de conducción (raquídea o epidural) se debe administrar antes
- Si se aplica bloqueo de pudendos o infiltración local se debe administrar después de la exploración preliminar y cuando este todo listo para el parto

APLICACIÓN DE LAS RAMAS Y PARTO



→ Cuando la cabeza está colocada en posición LOA o ROA primero se coloca la rama más inferior.

- Ramas se adaptan a los lados de la cabeza fetal
- Se sujeta a la perfección solo cuando el eje longitudinal de las ramas corresponde al diámetro **OCCIPITO MENTONIANO** (mayor parte de la rama en la cara)

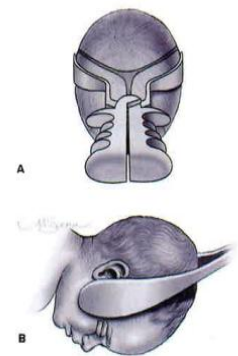


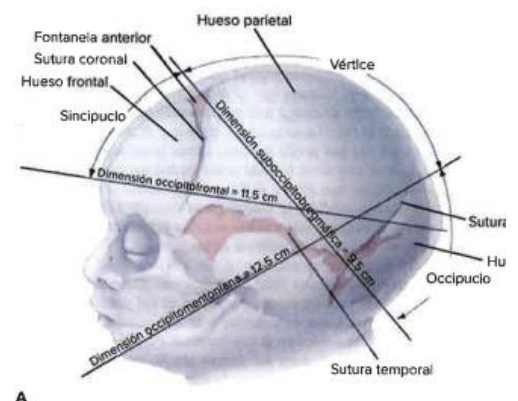
FIGURA 29-6 A. El fórceps se coloca y articula en forma simétrica. B. El vértice se encuentra en OA. (Reproducida con autorización de Yeomans ER. Operative vaginal delivery. En Yeomans ER, Hoffman BL, Gilstrap LC III, y col (eds): Cunningham and Gilstrap's Operative Obstetrics, 3a ed. Nueva York, NY: McGraw Hill; 2017).

Colocación y aplicación del fórceps

Una colocación inadecuada de las ramas se asocia con mayor morbilidad materna y fetal, por ello hay que verificar la relación correcta del instrumento con las **suturas craneales fetales ANTES** de iniciar la tracción.

Posición correcta de las ramas

- **Posición (OA):** Ramas a la misma distancia de la **sutura sagital**, y a igual distancia de la sutura lambdoidea adyacente
- **Posición (OP):** Ramas se colocan simétricamente respecto a la **sutura sagital**. Deben quedar a la misma distancia de cada **sutura coronal**.



Articulación del fórceps

- Después de colocar las ramas, **SI NO SE** puede articular debemos evaluar las relaciones del fórceps con las suturas craneales.
- Colocación **CORRECTA** → fórceps no debe deslizarse y permite aplicar tracción de forma segura.

Corrección del asinclitismo

- Puede emplear un **FÓRCEPS DE LUIKART**.
- **Una vez colocado:** Uno de los mangos se extiende más allá del otro a lo largo de su eje longitudinal y se corrige jalando, empujando en cada rama dentro el seguro deslizante
- Ajuste se continúa hasta que los protectores digitales quedan alineados.

Rotación y tracción

- Se realiza la rotación hacia OA. Posteriormente se aplica **tracción suave e intermitente**, dirigida hacia **abajo y hacia afuera**, mientras la madre realiza esfuerzos de pujo.
- Tracción se mantiene hasta que el **perineo comienza a distenderse**.

Tracción y nacimiento de la cabeza:

A medida que la cabeza fetal desciende en el canal del parto, el vector de las fuerzas de tracción cambia progresivamente, pasando de una dirección inicial hacia abajo a una dirección gradual hacia arriba.

**** Es importante IMITAR LO MÁS POSIBLE LOS MECANISMOS del parto espontáneo.**

USO DE TRACTOR DE BILL:

En muchos fórceps se puede colocar un tractor de Bill sobre los protectores digitales del instrumento. Este dispositivo cuenta con:

- Una flecha
- Una línea indicadora

Cuando la flecha apunta directamente a la línea, significa que la tracción se está aplicando en la dirección correcta

Aplicación de la fuerza de tracción:

No es posible medir con exactitud la cantidad de fuerza ejercida con el fórceps en cada paciente. Por esta razón, se recomienda que la tracción:

- Intermitente
- Se detenga entre contracciones uterinas
- Se realice de forma similar al trabajo de parto espontáneo

Excepto en situaciones de **URGENCIA OBSTÉTRICA**, el nacimiento debe ser lento, deliberado y cuidadoso, con el fin de evitar una compresión excesiva de la cabeza fetal.

→ La tracción se aplica solo **DURANTE LAS CONTRACCIONES UTERINAS**, y los pujidos maternos contribuyen a aumentar la fuerza expulsiva.

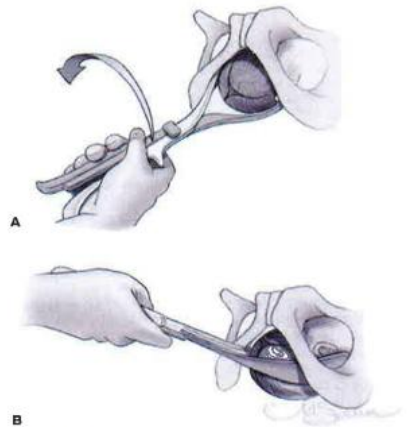


FIGURA 29-7 En caso de LOA, el vértice se rota desde esta posición hasta OA (flecha). (Reproducida con autorización de Yeomans

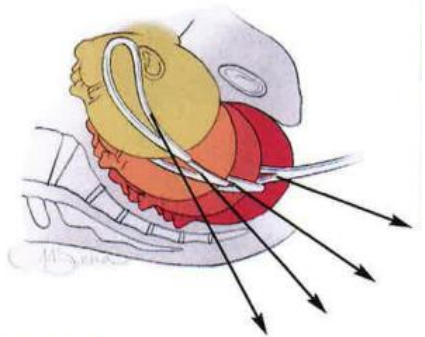


FIGURA 29-8 Con el fórceps bajo, la dirección de la tracción delicada para el parto de la cabeza está señalada (flechas). (Reproducida con autorización de Yeomans ER: *Operative vaginal delivery*. En Yeomans ER, Hoffman BL, Gilstrap LC III, y col (eds): *Cunningham and Gilstrap's Operative Obstetrics*, 3a ed. Nueva York, NY: McGraw Hill; 2017).

Episiotomía y distensión perineal

- Durante la **TRACCIÓN**, cuando el occipucio fetal comienza a distender la vulva, puede realizarse una episiotomía si está indicada.

Finalización del parto

El parto puede finalizar de diferentes maneras:

- Algunos médicos mantienen el fórceps colocado para controlar la salida de la cabeza.

Sin embargo, el volumen de las ramas del fórceps puede aumentar la distensión del perineo y el riesgo **de laceraciones o ampliación de la episiotomía**.

- Se retira el fórceps antes del nacimiento completo de la cabeza, permitiendo que el parto finalice con los pujidos maternos.
- NO retirarlo antes porque él bebe se puede regresar.

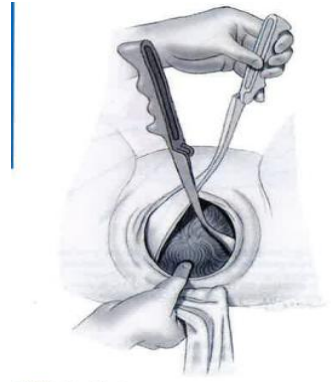
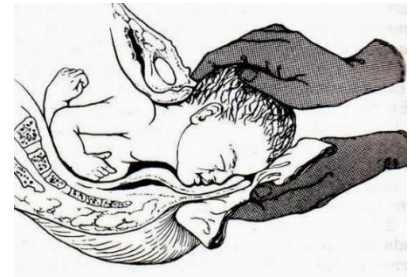


FIGURA 29-9 Las hojas se extraen en el orden opuesto al que se colocaron. Los dedos de la mano derecha, cubiertos con una toalla estéril, sostienen el perineo. El pulgar se coloca directo sobre la cabeza para evitar que salga en forma repentina. (Reproducida con autorización de Yeomans ER. *Operative vaginal delivery*. En Yeomans ER, Hoffman BL, Gilstrap LC III, y col (eds). *Cunningham and Gilstrap's: Operative Obstetrics*, 3a ed. Nueva York, NY: McGraw Hill; 2017).

Maniobras complementarias

Maniobra **MODIFICADA DE RITGEN** para ayudar a los pujidos maternos y facilitar la salida de la cabeza. Además, se recomienda sostener el perineo durante la expulsión, con el objetivo de regular las fuerzas expulsivas y disminuir el riesgo de traumatismo perineal.

****Extensión controlada para evitar laceraciones.**



ROTACIÓN MANUAL

Posiciones OT y OP tienen una flexión imperfecta y un diámetro cefálico más amplio, lo que desacelera el descenso fetal y alarga 2da etapa del trabajo de parto. La **ROTACIÓN MANUAL** a OA mejora las condiciones y reduce el traumatismo perineal.

Rotación digital:

Moldeamiento cefálico, las suturas craneales pueden superponerse, formando un borde óseo palpable.

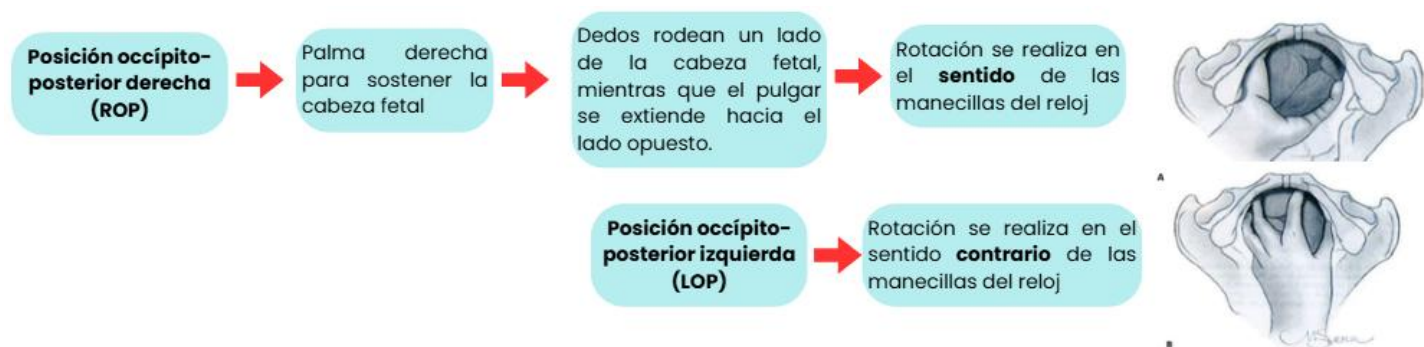
→ **Maniobra:** Operador puede enganchar dos dedos en este borde y aplicar fuerzas paralelas al cráneo fetal → rotar el occipucio hacia la parte anterior.

→ Indicaciones:

- Entre contracciones.
- Avances de la rotación ocurren durante los pujidos maternos.
- Cada intento produce pequeños grados de rotación progresiva.
- Algunos casos se requieren varios intentos para lograr la rotación completa del occipucio hacia anterior.

Rotación manual:

Se hace cuando se requiere un mayor control, introduciendo una mano abierta en la vagina.



Acciones simultáneas durante la rotación

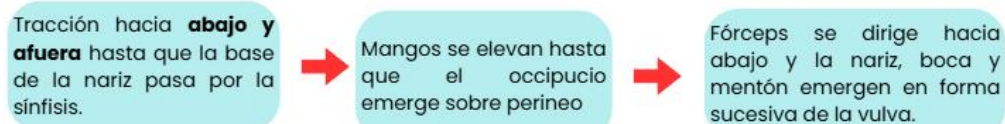
Durante la rotación manual se realizan tres acciones de forma simultánea entre contracciones:

Flexión de la cabeza fetal	Ligero cambio de estación de la cabeza fetal	Maniobra abdominal complementaria
Permite presentar un diámetro cefálico menor, facilitando la rotación y el descenso	- Desplaza la cabeza a un nivel de la pelvis con mayor espacio para completar la rotación - No confundir este movimiento con el desenganche de la cabeza EVITAR	- Colocar la otra mano sobre el abdomen materno, en el lado correspondiente. - Con esta mano se eleva la espalda fetal hacia arriba y hacia la línea media, coordinando el movimiento con la rotación interna de la cabeza.

Posiciones occipito posteriores persistentes

- Puede nacer de manera espontánea en OP
- Rotar de forma manual o instrumental a OA
- Nacer en OP con fórceps o ventosa.

Dificultad para rotación → **PELVIS ANTROPOIDE**.



Consecuencias de partos OP:

- Laceraciones perineales graves y de episiotomías extensas
- Parálisis de ERB** y del **nervio facial**

Para **rotar OP a OA** → **FÓRCEPS DE KIELLAND** por su curvatura pélvica menos pronunciada

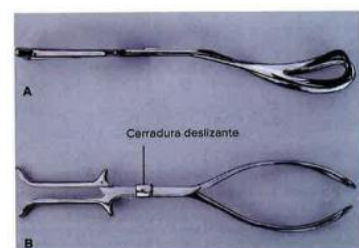


FIGURA 29-12 Fórceps de Kielland. Sus características principales son la curvatura pélvica mínima (A), la cerradura deslizante (B) y su peso ligero.

Posiciones occipito transversas

→ Es necesario rotar, para esto se puede de forma manual o instrumental hasta OA

Uso de fórceps

- Tradicional o **KIELLAND**. Con este último, cada mango tiene un botón pequeño y las ramas se colocan de manera que este botón esté orientado hacia el occipucio.

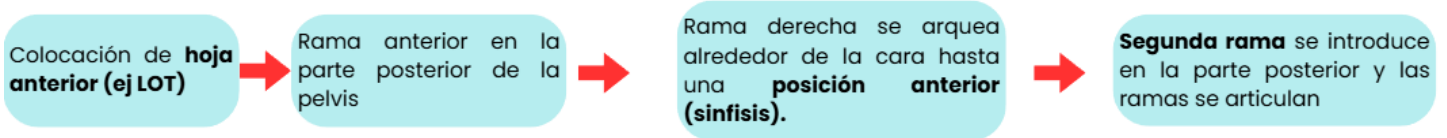
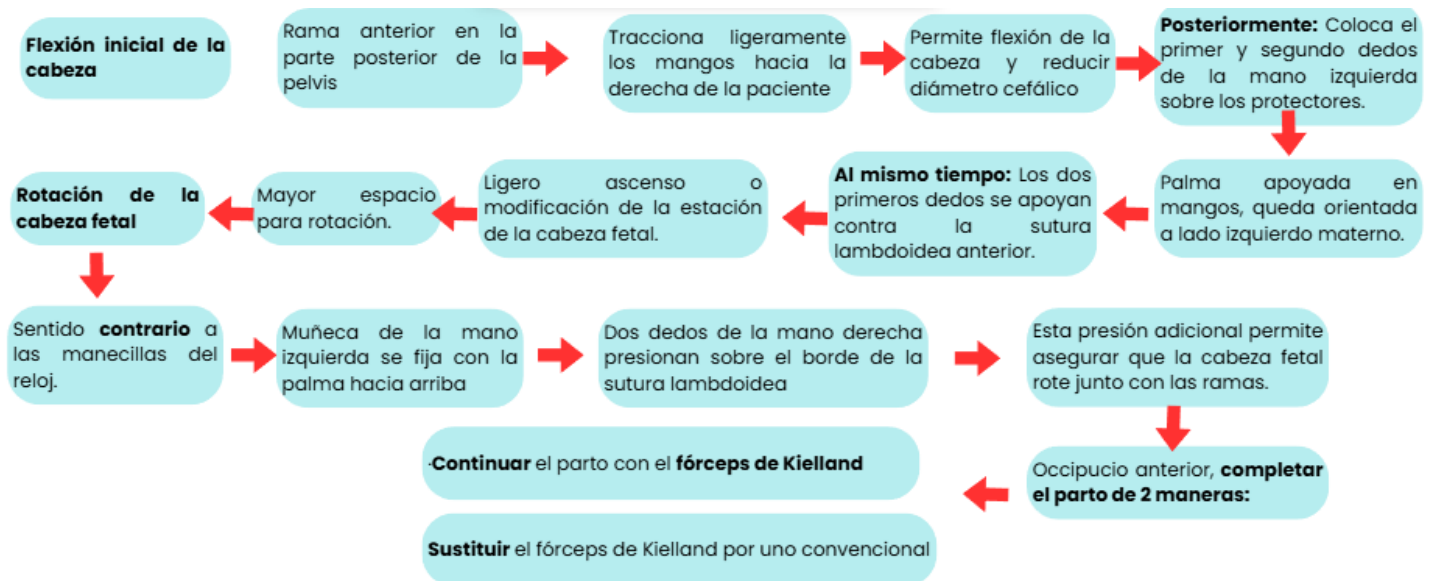
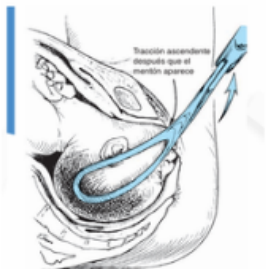
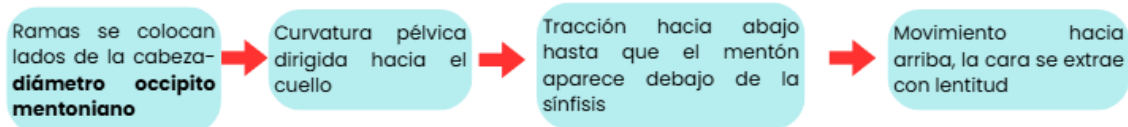


FIGURA 29-13 A. Aplicación de la rama derecha del fórceps de Kielland en una cabeza en posición LOT. La articulación de esta rama (color azul) al final estará de frente al occipucio. B. La rama derecha se lleva hasta su posición final detrás de la sínfisis del pubis. C. Inserción de la rama izquierda del fórceps de Kielland en situación posterior a lo largo del hueco del sacro. Esta rama se inserta hacia la derecha materna de la rama anterior para ayudar a cerrar la cerradura desilzente. (Reproducida con autorización de Yeomans ER: *Operative vaginal delivery*. En Yeomans ER, Hoffman BL, Gilstrap LC III, y col (eds): *Cunningham and Gilstrap's Operative Obstetrics*, 3a ed. Nueva York, NY: McGraw Hill; 2017).



Presentaciones de cara



→ **NO SE DEBEN APLICAR** fórceps en las presentaciones de **MENTÓN POSTERIOR** puesto que el parto vaginal es imposible, a menos que el feto sea muy pequeño.

Complicaciones:

Efectos a corto plazo del parto vaginal quirúrgico → **retención urinaria y disfunción vesical**

- La retención casi siempre desaparece después de 24 a 48 h con una sonda vesical pasiva

MORBILIDAD

- Estación más alta y el mayor grado de rotación aumentan la dificultad del procedimiento y la probabilidad de una lesión.
- Morbilidad es más comparable a la de una cesárea
- Alternativa del parto vaginal quirúrgico es la cesárea.

1) Laceraciones:

Indicaciones del parto vaginal quirúrgico son las mismas que las de la **EPISIOTOMÍA**.

- **Tercer y cuarto grados (OASIS)** – Más frecuente que con ventosa sobre todos si es en línea media *OP frecuente.
- Pared vaginal
- Cuello uterino

Protección: Desarticulación y extracción oportunas del fórceps evitan la distensión perineal completa

2) Infección y morbilidad en los siguientes embarazos

- Cesárea aumenta el riesgo de placenta previa, el espectro de la placenta acreta, rotura uterina y lesiones de otros órganos por adherencias, así como la infección puerperal de la herida o el útero
- Los autores consideran que la administración de antibióticos en las que se someten a un parto vaginal quirúrgico

3) Trastornos del piso pélvico

- Incontinencia urinaria, incontinencia anal y prolapso de los órganos pélvicos (POP).

Mecanismos propuestos

- Daño estructural o deservación del piso pélvico secundaria a las fuerzas ejercidas durante el nacimiento.

Morbilidad perinatal

1) Lesión perinatal aguda

Ventosa	Fórceps
• Lesiones más frecuentes • Cefalo- hematoma, hemorragia sub- galeal (extracraneales) • Hemorragia retiniana, ictericia neonatal secundaria a hemorragias • Fractura de clavícula • Laceraciones de cuero cabelludo • Distocia de hombros con ambas	• Principal complicación el trauma neonatal • Lesion de nervio facial y plexo braquial • Fractura deprimida de cráneo • Abrasion corneal • Mayor índice de traumatismo y acidemia en la sangre del cordón umbilical con el parto con fórceps medio

2) Mecanismos de la lesión aguda

Cefalohematomas o hemorragia subgaleal	Hemorragia intracraneal	Parálisis del nervio facial	Lesión del plexo braquial
Succión y quizá la rotación durante la extracción con ventosa ocasiona una laceración vascular primaria.	Resultado de una fractura de cráneo que lacera los vasos o por la rotura vascular aislada a causa de las fuerzas ejercidas.	Una de las ramas del fórceps comprime al nervio contra los huesos faciales	Mientras la cabeza fetal desciende a lo largo del canal del parto, a veces los hombros permanecen en el estrecho superior de la pelvis, esto se corrige por medio de tracción, pero con distensión concomitante del plexo braquial

Efectos de anestesia epidural:

- Disminuir la rotación espontánea de la cabeza fetal
- Reducir la velocidad del segundo periodo del parto
- Aumentar la probabilidad de parto instrumentado

PARTO ASISTIDO CON VENTOSA

Diseño de la ventosa

Se crea succión dentro de una copa que se coloca sobre el cuero cabelludo del feto de manera tal que la tracción aplicada sobre la copa ayude al nacimiento *ayuda evitar el traumatismo materno.

- **Copa** → metal o plástico
 - **Copa blanda:** cúpula flexible con forma de campana
 - **Copa rígida:** aplanada con forma de hongo y una cresta circular alrededor del borde de la copa.
- **Eje** → flexible o semiflexible
- **Generador de vacío**
 - **Copas de metal:** mayor índice de éxito, pero también un mayor índice de lesiones de la piel cabelluda “cefalohematomas”
 - **Copas blandas:** menor frecuencia de lesión de la piel cabelluda.
 - Ejes flexibles: con forma de tubo se prefieren para las posiciones OP o el asinclitismo

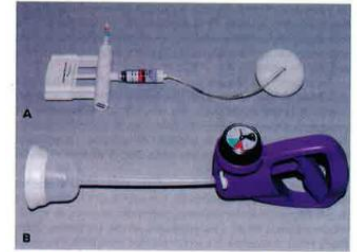


FIGURA 29-14 Sistemas de parto con ventosa. A. La Kiwi OmniCup tiene una bomba manual que genera vacío unida por un tubo flexible a la ventosa de plástico rígido con forma de hongo. B. La Mityvac Mystic II MitySoft Bell Cup tiene una ventosa blanda unida por un mango semirrígido a una bomba manual.

CUADRO 29-2. Ventosas en copa para el parto vaginal quirúrgico.

Tipo de copa	Fabricante
Ventosa en campana blanda	
GentleVac	OB Scientific
Kiwi ProCup	Clinical Innovations
MitySoft	Cooper Surgical
Pearl Edge	Cooper Surgical
MityVac Reusable Silicone®	Cooper Surgical
Secure Cup	Utah Medical Products
Soft Touch	Utah Medical Products
Tender Touch Ultra	Utah Medical Products
Velvet Touch®	Utah Medical Products
Silic Cup	Medela
CoesAid®	Medela
Copa rígida	
Flex Cup	Utah Medical Products
M-Style	Cooper Surgical
Super M-Style	Cooper Surgical
M-Select®	Cooper Surgical
Kiwi OmniCup®	Clinical Innovations
Kiwi Omni.MT	Clinical Innovations
Kiwi Omni-Ci	Clinical Innovations
Bird Cup®	Medela
Malmström Cup	Medela

®Copas reusables.

®Adecuadas para posiciones occipitales posteriores o asinclitismo.

®Para extracciones a través de una histerotomía durante la cesárea.

Técnica

Punto de flexión: se encuentra a lo largo de la sutura sagital, a unos 3 cm del centro de la fontanela posterior y a unos 6 cm del centro de la fontanela anterior.

EVITAR:

- Evitar colocar la copa en un sitio más anterior del cráneo fetal, cerca de la fontanela anterior, puesto que esto provoca **extensión cervical** durante la tracción a menos que el feto sea pequeño.
- Colocación asimétrica en relación con la sutura sagital acentúa el **ASINCLITISMO**.

Importante:

- Si queda tejido blando materno atrapado, se predispone a que la madre sufra laceraciones y a que la copa se suelte, lo que suele llamarse **“separación abrupta”**.
- Palpar la circunferencia completa de la ventosa antes y después de crear el vacío y de nuevo antes de ejercer tracción

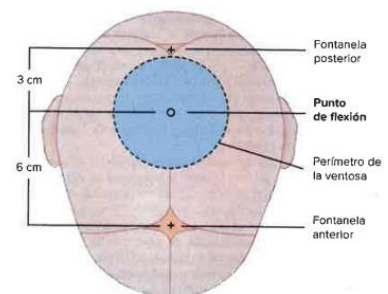


FIGURA 29-15 Esquema que muestra la colocación correcta de la ventosa en el punto de flexión. A lo largo de la sutura sagital, este punto yace a 3 cm de la fontanela posterior y a 6 cm de la fontanela anterior.

Proceso:

- Una vez creada la succión, se sujeta el mango del instrumento y se ejerce tracción
- Número de tirones necesarios aumenta con la altura de la estación, pero por lo general varía de uno a cuatro.
- Esfuerzos son intermitentes y cada tirón se coordina con los pujidos maternos.

CUADRO 29-3. Conversión de las presiones de la ventosa.

mmHg	cm Hg	Pulgadas Hg	lb/pulgadas ²	kg/cm ²
100	10	3.9	1.9	0.13
200	20	7.9	3.9	0.27
300	30	11.8	5.8	0.41
400	40	15.7	7.7	0.54
500	50	19.7	9.7	0.68
600	60	23.6	11.6	0.82

- Evitar la torsión manual de la ventosa puesto que se puede separar o formar una cefalohematoma y, con las ventosas metálicas, laceraciones de la piel cabelluda con forma de cortapastas
- Una vez que nace la cabeza, la presión de la succión se reduce y se retira la ventosa.

Posiciones OP

- **NO** se debe usar la rotación, debido a que la colocación correcta en el punto de flexión y la línea de tracción, la cabeza rota por sí

EXTRAS:

- Tracción siempre se hace como la curvatura pélvica HORIZONTAL
- Se encajan con diámetro biparental y siguen el diámetro occipitomentiano
- 2 ramas mojadas con isonide o gel – lubricación
- Rama debe deslizarse sola sin topar con nada
- **TRANSVERSA DERECHA:** primero se pone la rama izquierda
- Sobre todo, quedan en el **HUESO PARIETAL Y OREJA**
- Se recomienda que la rotación se haga solo con una rama ya de pues la tracción es con las 2 ramas
- A la vez que va saliendo la cabeza hay que quitar fórceps
- Se tienen que hacer **EPISIOTOMÍAS AMPLIAS** – menos riesgos que se hagan laceraciones de 3er y 4to grado
- **Incontinencia, distocias genitales, incontinencia urinaria, lesiones del ano** son complicaciones
- Fórceps salinas - Mexicano
- Rotaciones en Occipital posterior son un riesgo, se recomienda mejor usar los fórceps y extraerlo de esa manera